جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سماح عبدالمعتمد عبدالرحيم عبدالرسول
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الحسين **العنوان :** حلوان
رقم البطاقة : 25810052400844 **رقم التليفون :** 01122272905 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 05-10-1958 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سماح عبدالمعتمد عبدالرحيم عبدالرسول
National ID: 25810052400844

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Pathology Report

Name: [illegible] Age:58years.

Clinical data: Left breast mass.

Specimen type: Left MRM.

Date(received) :14/12/2020 Date(reported) :28/12/2020

Lab. Number: 2081 Hospital Number: [illegible]/2020

Gross Description:

Three specimens received:

1-Left MRM specimens measured 23x21x4cm, covering skin 26x22cm, nipple was unremarkable grossly, cut section revealed vaguely defined tan firm gritty mass 3.5x2.5x2cm, away 3cm, from deep tissue and 0.7cm from skin.

In the same container two skin covered breast tissue 16x11& 12x7cm and was unmarkable.

2-Left axillary cleansable : multiple fatty tissue fragments 7x4cm collectively, enclosing 11 nodules up to 1cm.

3-Sl.N: fatty tissue fragment 3x2cm enclosing 4 nodules up to 1cm.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed breast tissue infiltrated by invasive, malignant tumor formed of nests and trabeculae of moderately anaplastic ductal epithelial cells with desmoplastic stroma.

The examined axillary LNs were free of tumor deposits (0/11).

The examined sentinel LNs showed tumor deposits in 2 nodules (2/4) with focal extra capsular extension .

total LN's status (2/15).

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

اسم المريض : سماح عبدالمعتد عبدالرحيم

تاريخ الخدمة : 2020/10/28

Immunohistochemistry report

Lab-No.:20/700

-Procedure:

-Sections Immunestained for ER, PR, KI67 and Her2neu using supersensitive monoclonal antibodies with Roche envision (Dextran substrate polymer) flex detection system. Pretreatment for heat induced epitope retrieval (HIER) was performed using flex target retrieval solution. Blocking of endogenous peroxidase was performed using Roche peroxidase blocking reagent DAB was used as a chromate.

Results:

ER: Marked positivity, score (8/8).

PR: Marked positivity, score (8/8).

Her2: Negative, score = 0

KI67: High KI67 (20-25%).

N.B: the slides are delivered to the patient.

Prof.Dr.Ibrahim Hassan

Date 28-O.t. 2020 Time: 15:33pm

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name: Samah Abd Almoutamed Abd Al Rahim Abd Al Rasoul	Date : 14/09/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 64 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 18934

QST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Known case of breast cancer previous report dated 15/11/2020:

1. ***Chest:***
   - Status post left MRM showing no operative bed masses or collections.
   - Still seen few bilateral subcentimeteric pulmonary nodules are seen the largest is seen in the left lower lobe basal segment measuring about 5 mm in diameter.
   - Still noted prominent pre-carinal lymph node is seen measuring about 11 x 7 mm.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
   - Still noted lower neck cuts show enlarged thyroid gland with heterogeneous pattern with multiple nodules and retro-sternal extension, the largest is seen on the right measuring about 3.3 x 2 cm.
2. ***Abdomen and pelvis:***
   - The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic collections.
   - L3 osseos hemangioma and D5 tiny sclerotic focus. No suspicious lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

- ***Known case of breast cancer status post MRM showing no operative bed masses or collections.***
- ***Still noted few bilateral subcentimeteric pulmonary nodules likely of benign nature.***

Dr. Ahmed M. Rozeka

Dr. Ola Magdy, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Diagnosis:

Left breast mass, Left MRM.
Invasive duct carcinoma grade II,
Positive lymphatic tumor emboli
Positive perineural invasion.
Free nipple, areola and resection margin.
Positive 2/15 lymph nodes with focal extrascapular extension .
Stage p T2 p N1a.

Prof. Dr .Amal Hready
Dr.Enas Mohammed Ali

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Samah Abd Almoutamed Abd Al Rahim Abd Al Rasoul	Date : 23/10/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 5839/2020	Pat. ID: 18934

DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Report:

- Left MRM:
  - Operative bed shows no mass or collection
  - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
  - ACR B
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of the right breast (BIRADS 1)

Signature Dr. Peter Nashat

23/10/2023 3:08 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

جوستافروسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي صحة مصر

MDT FORM ٧ / ٨ / 20 ٢٥ G

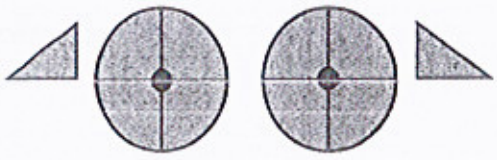
Name	سماح عبدالسعيد	MRN	٥٨٢٩ / C.C.
		ID	01122272905
Age	٥٨٢٩/C.C.	Phone	
Menopausal status	65 y. old	Marital status	
NRS SCORE	Post menopusal	Family history	
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity			

Clinical Data

BX: IDC G2

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
7/8	6/8	-ve	

R L



Sonomammography:
12/2020: Lt MRM (T2 N0 M0) (2/15)

Mets Workup:

Adj: AC x 4
Taxwol weekely x 12
PoRTH
Adj Femara (Started 10/2021)

TNM

Recommendations:

MDT OUTCOME & PLAN

Ax Continue Adj Femara

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]